🫀 Fisiopatología · 3er examen · Lo imprescindible

Unidad 3 · La patología: estudio de la enfermedad · pregunta directa → respuesta corta

1 · Agentes y factores patógenos

¿Proceso patológico? → Proceso que provoca **cambios estructurales, bioquímicos o funcionales** del organismo.

¿Agente patógeno? → **Externo**, actúa **directamente sobre la célula**: **físicos, químicos, biológicos**.

¿Factor patógeno? → **Se genera a partir de otros procesos** (hipoxia por trombosis). Son **hipoxia, oxidación + inmunológicos, genéticos, nutricionales**.

¿Agentes físicos? → **Temperatura** (31-41 ºC), **presión atmosférica**, **electricidad** (electroporación → edema; lesión térmica → necrosis), **radiaciones** (mutaciones, tumores, teratogenia) y **traumatismos**.

¿Químicos y biológicos? → **Químicos:** fármacos, reactivos, desinfectantes, pesticidas, humos. **Biológicos:** microorganismos, endoparásitos y sus secreciones → **infección, alergia o toxicidad**.

¿Hipoxia y sus causas? → **Falta de oxígeno → muerte celular.** Pérdida de **riego** · pérdida de **capacidad transportadora de O2** (anemia) · **oxigenación inadecuada** (insuficiencia respiratoria o cardiaca).

¿Radicales libres? → **Muy reactivos, introducen oxígeno** → oxidación y daño del **ADN**. Se forman ante **radiaciones ionizantes, traumatismo, tejidos isquémicos**. Dañan **membrana (peroxidación lipídica), enzimas y ADN**.

2 · La célula: salud, lesión y muerte

¿Homeostasis celular? → Mantenida por **membrana, secreción, energía (autonomía) y mitosis**.

¿Estímulo vs agente patógeno? → Estímulo: respuesta **fisiológica** (cambios moderados). **Agente:** respuesta **fisiopatológica** (lesión).

¿Dónde se lesiona la célula? → Membrana, respiración celular, síntesis de proteínas, reproducción.

¿Lesión reversible? → Desaparece cuando el agente deja de actuar (edema celular, bomba Na/K, ATP).

¿Lesión irreversible? → Fragmentación de la **membrana**, lisis del **retículo**, disfunción **mitocondrial**, alteraciones del **núcleo**.

¿Picnosis, cariorrexis, cariolisis? → Picnosis: núcleo se retrae y condensa. **Cariorrexis:** se fragmenta. **Cariolisis:** se disuelve. ⚠️ La diapositiva 26 tiene cruzadas las dos últimas.

¿Necrosis celular? → Proceso **no fisiológico** por un **agente externo** que lleva a la muerte celular: **desnaturalización de proteínas** + **digestión enzimática** (**autolisis** propias / **heterólisis** de otras células).

¿Necrosis vs apoptosis? → Necrosis: se **hincha**, se rompe → **inflamación**. **Apoptosis:** se **encoge** → cuerpos apoptóticos → **fagocitosis**.

3 · Adaptaciones celulares y tisulares

¿Atrofia? → Disminución de tamaño y función por pérdida de sustancia.

¿Hipertrofia? → Aumento de tamaño por aumento de **masa protoplasmática**, con más función (más demanda o estímulo endocrino).

¿Metaplasia? → Un tipo celular adulto se transforma en otro; reversible si cesa el estímulo. **No es neoplasia.**

¿Displasia? → Aspecto anormal por alteración de la **maduración** (ADN alterado). No es neoplasia pero **puede evolucionar** a ella.

¿Reducción del tejido? → Atrofia simple (células pequeñas) · **numérica** (menos células) · **pseudoatrofia** (parte necrosada).

¿Aumento del tejido? → Hipertrofia estricta (células grandes) · **hiperplasia** (más células) · **pseudohipertrofia** (grasa, edema o células neoplásicas; ej. gemelar).

4 · Necrosis tisular y reparación

¿Destinos del tejido necrótico? → Expulsión, **reparación** (fagocitosis + renovación) o **aislamiento** (calcificación o encapsulación).

¿Tipos de necrosis? → Coagulativa (isquemia; + bacterias = **gangrenosa**) · **licuefactiva** (líquida y viscosa) · **grasa** (adipocitos → ácidos grasos) · **caseosa** (coagulativa + licuefactiva; **tuberculosis**).

¿5 procesos fundamentales? → Edema, inflamación (hinchazón, dolor, calor, enrojecimiento), **tumoración, necrosis, ulceración**.

¿Tejidos según proliferación? → Lábiles (siempre: piel, mucosas, médula) · **quiescentes** (si hay estímulo: hígado, riñón...) · **permanentes** (G0: neuronas y músculo estriado).

¿Fibrosis? → Exceso de tejido conectivo fibroso por reparación **cuando falla la proliferación**; el órgano **pierde función**.

5 · Estudio de la enfermedad

¿Patología? → Rama de la medicina encargada de los procesos patológicos.

¿Ramas? → Etiología (causa) · **patogenia** (mecanismo) · **semiología** (manifestaciones) · **anatomía patológica** (alteraciones estructurales) · **fisiopatología** (alteraciones funcionales).

¿Signo, síntoma, cuadro clínico, síndrome? → Signo: objetivo, cuantificable. **Síntoma:** sensación. **Cuadro clínico:** conjunto → enfermedad conocida. **Síndrome:** no se corresponde.

¿Términos clínicos? → Prefijo + raíz (poli-uria) · **raíz + sufijo** (artr-itis) · **epónimos** (nombres de persona o lugar) · **siglas y acrónimos** (pueden dar errores).

6 · La enfermedad

¿Enfermedad? → Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por **causas en general conocidas**, con **síntomas y signos característicos** y **evolución más o menos previsible**.

¿Nosología? → Parte de la medicina que **describe, explica, diferencia y clasifica** las enfermedades.

¿Clasificación por el agente? → Intrínseca/extrínseca · genética/adquirida · uni/multifactorial · agente conocido/desconocido · efecto inmediato/tardío · directa/indirecta.

¿Por duración? → Aguda < 3 meses · subaguda 3-6 · crónica > 6.

¿Fases? → Prepatogénica (sin cambios) → **patogénica** (cambios sin síntomas: **incubación** en infecciosas / **latencia** en degenerativas) → **clínica** (**prodrómico**, **clínico**, **resolución**).

7 · Diagnóstico y tratamiento

¿Diagnóstico, patognomónico, pronóstico? → Identificación de la enfermedad · signo que **permite diagnóstico directo** (Koplik-sarampión, Negri-rabia, tofo-gota) · **juicio hipotético** sobre cómo terminará.

¿Métodos clínicos? → Anamnesis + examen físico (inspección, palpación, auscultación, percusión) → **diagnóstico presuntivo**.

¿Percusión? → Sonoro (normal) · **hipersonoro** (enfisema) · **timpánico** (neumotórax) · **mate** (neumonía).

¿Métodos complementarios? → Confirmar/descartar, más datos, diagnóstico diferencial → **diagnóstico definitivo**. Son: **análisis clínicos, citología/anatomía patológica, imagen, electrodiagnóstico**.

¿Imagen? → Radiografía (rayos X) · **ecografía** (ultrasonidos, sin riesgo) · **RM** (imanes, sin radiación, cara) · **TC** (rayos X + ordenador, cortes) · **endoscopia** (ver, muestras, tratar).

¿Electrodiagnóstico? → ECG (corazón) · **EEG** (encéfalo: epilepsia, tumores, anestesia, sueño) · **EMG** (músculos).

¿Secuela? → Trastorno que persiste después de la curación.

¿Recursos terapéuticos? → Medidas higiénicas, farmacoterapia, quimioterapia, radioterapia, sueroterapia, dietoterapia, fisioterapia, cirugía, ortoprótesis y otras.